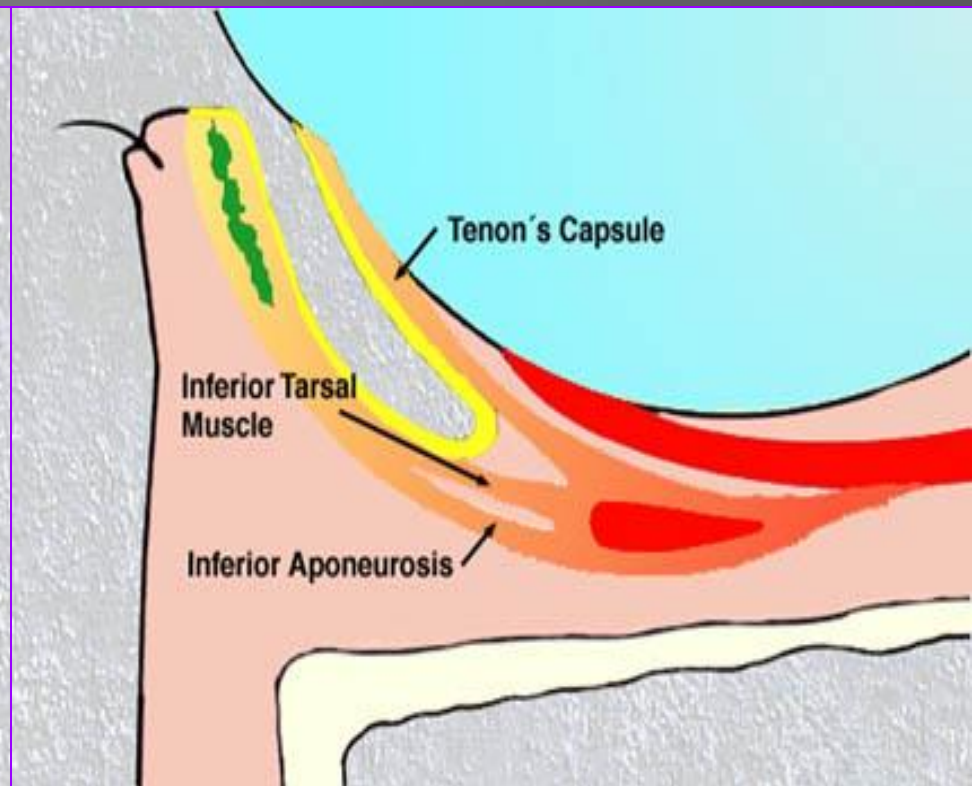
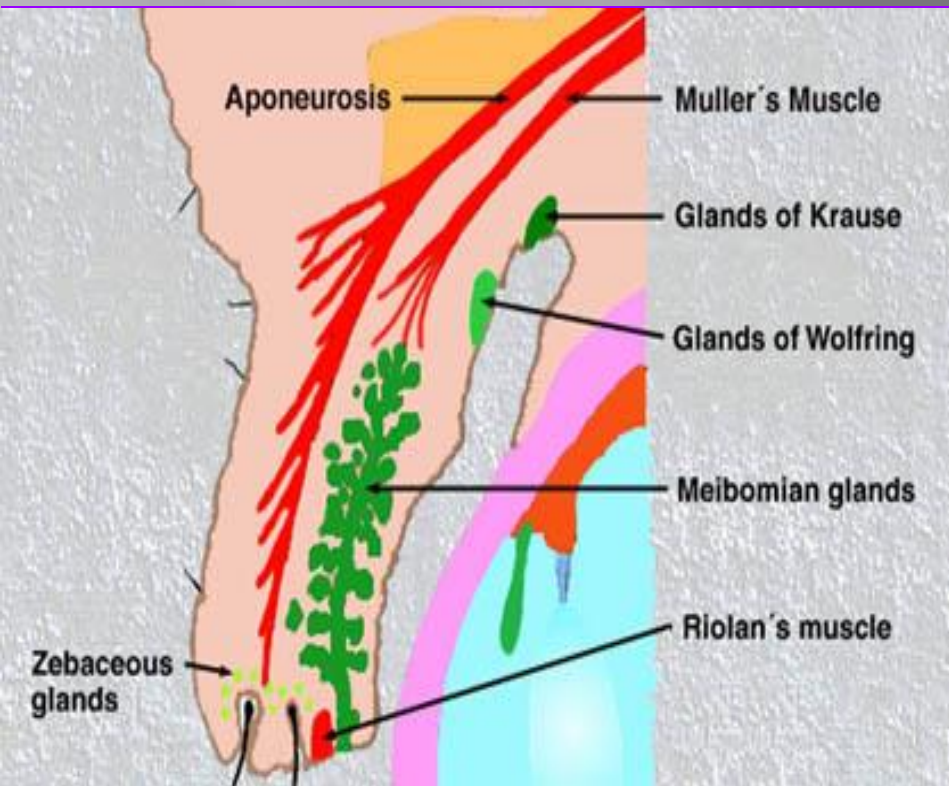


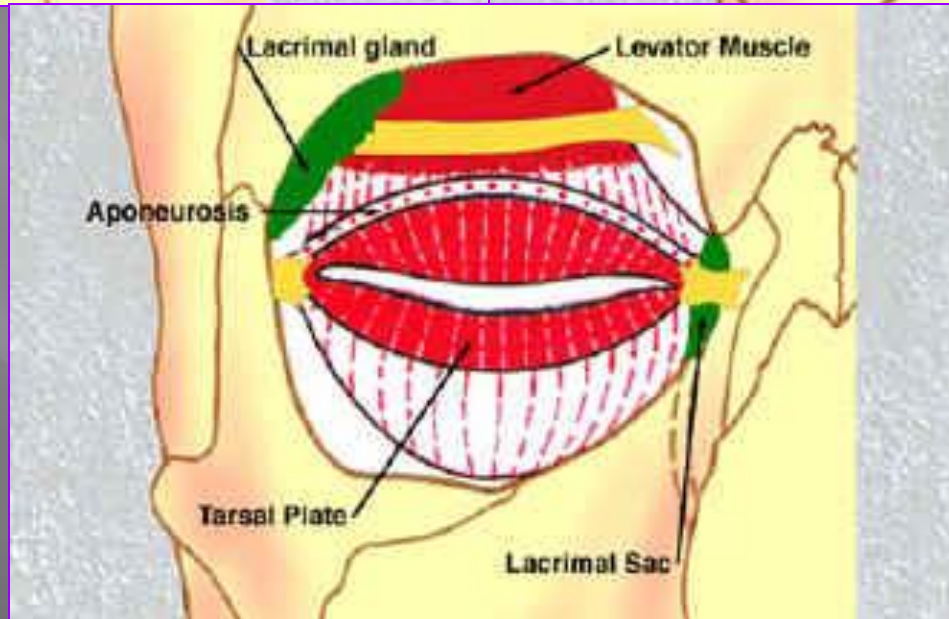
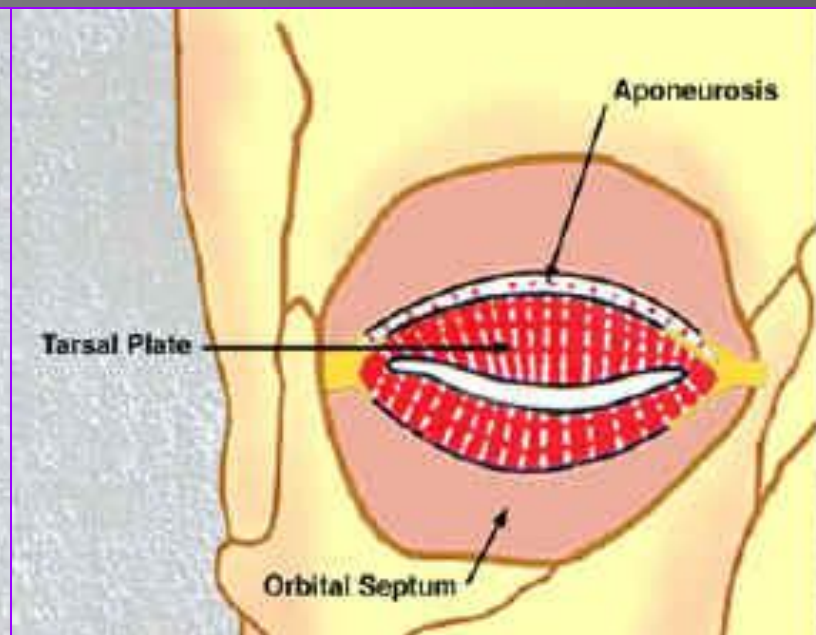
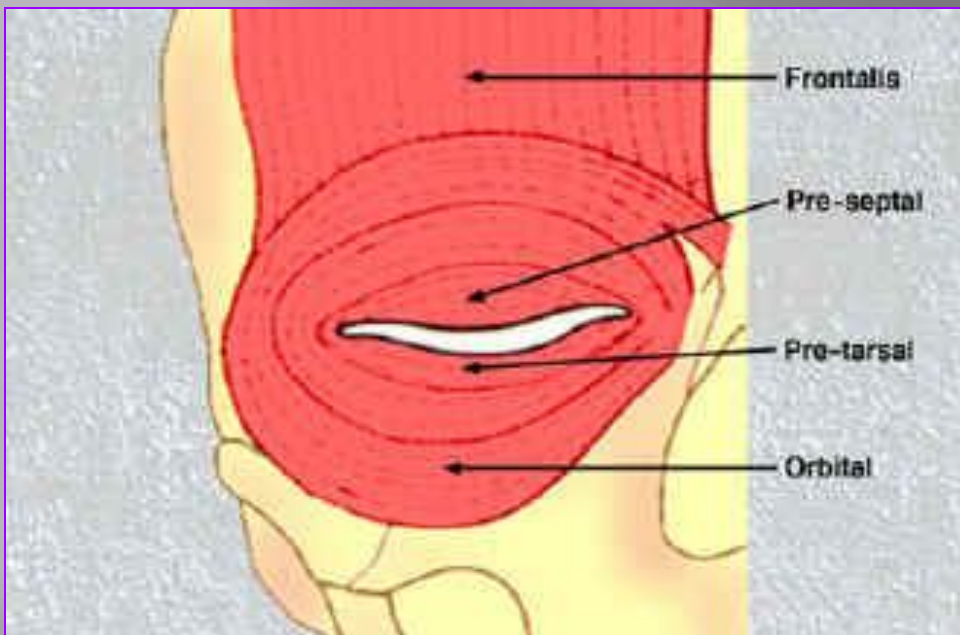
PALPEBRA

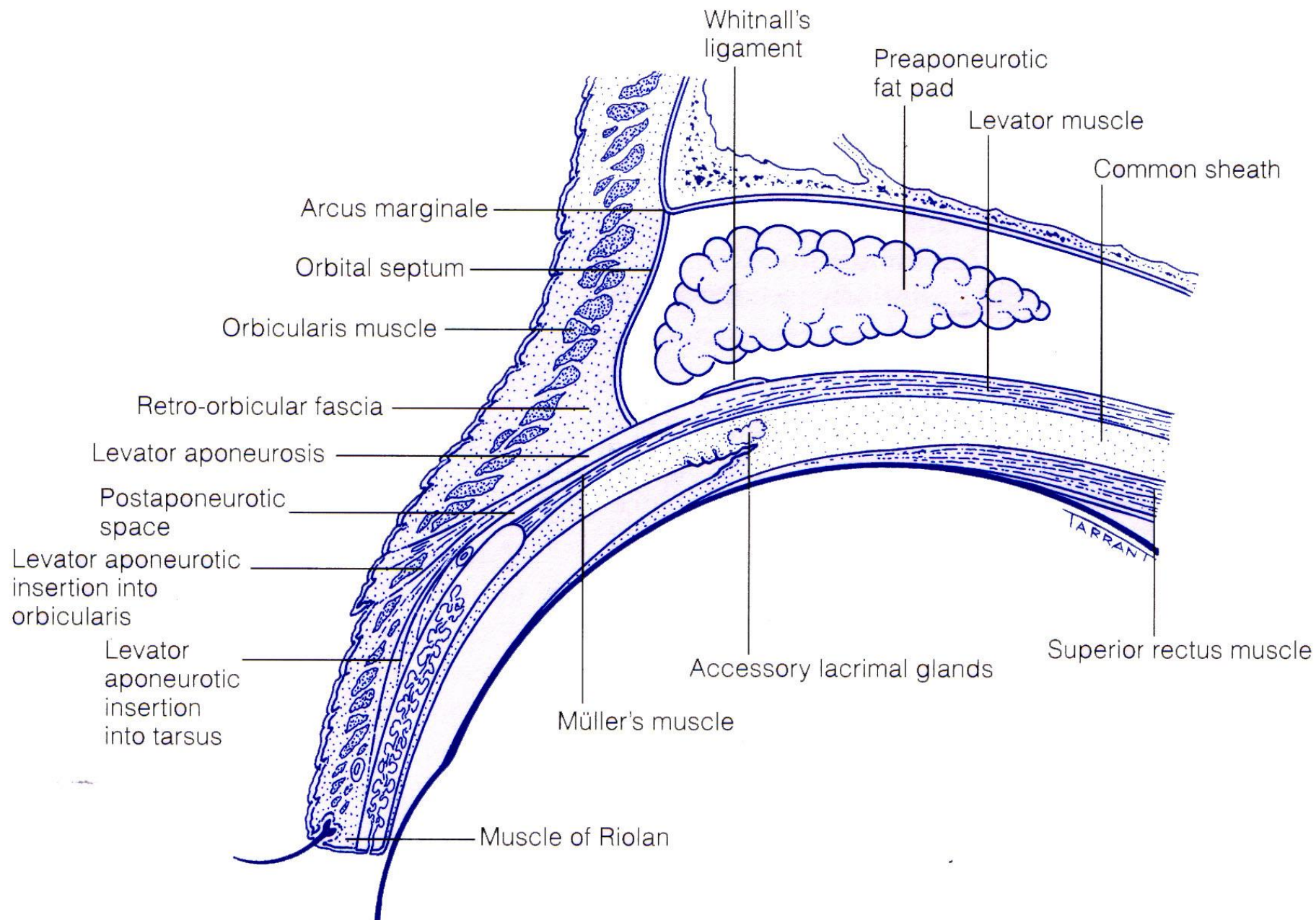
ORBITA

ONKOLOGI

Anatomi palpebra

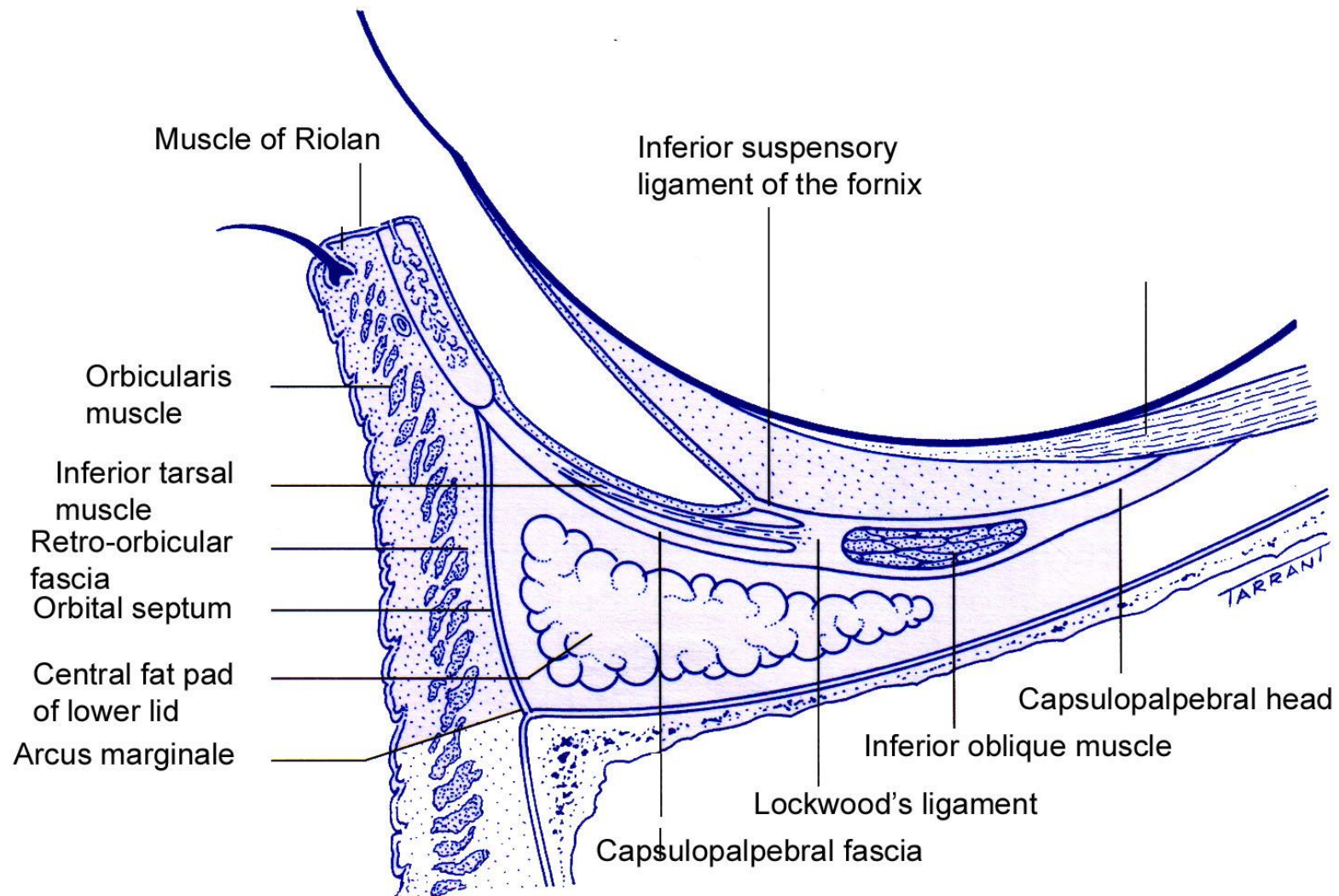






Diag. 1.6

Section through the upper eyelid



Diag. 1.8
Section through the lower eyelid

PALPEBRA

Fungsi :

- Melindungi bola mata
 - Fisik
 - Kimia
- Pembilasan dan pelicinan
 - Air mata
 - Sekresi kelj.
- Jalan masuk sinar
- Kedip – menyingkirkan debu / kotoran yang masuk

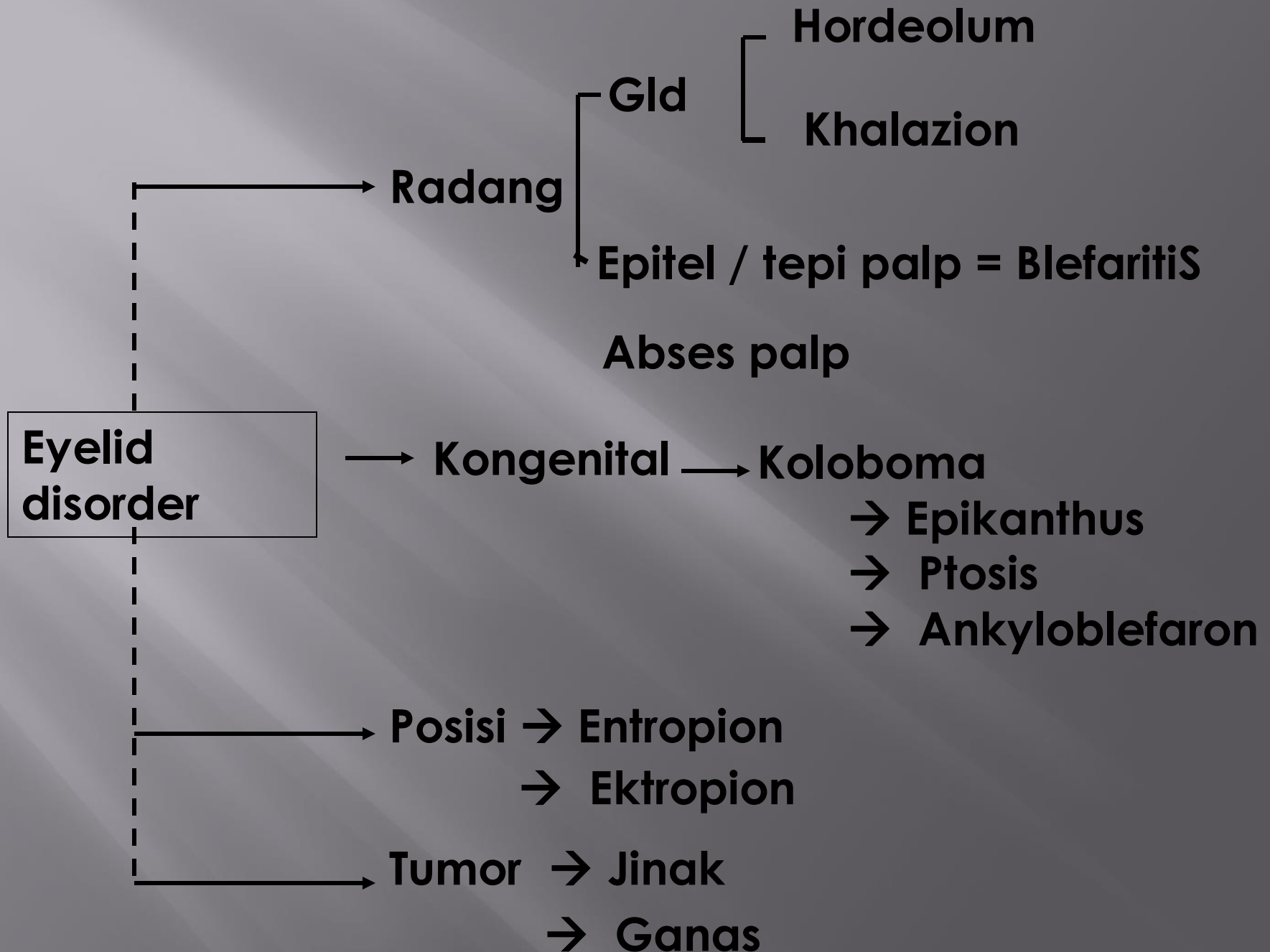
Menutup mata :

- Otot orbikularis okuli – N. VII (N. Facialis)

Membuka mata :

- Otot levator palp – N. III (N. Okulomotor)

Otot tarsalis → memegang tarsus



TUMOR

Jinak

- Nevus / tahi lalat
- Verucca
- Xanthelasma
- Hemangioma

Ganas

→ Basalioma → Laki-laki > 50 th.

- Palp. Inf.
- Rodent ulcer

→ Skuamus sel karsinoma

- Orang tua
- Pelan
- invasif
- Sakit + ulkus



Ulkus
rodent



Sq cell ca



Karsinoma kel
meibom

Infeksi dan Radang Kelopak Mata

1. Hordeolum

- Infeksi stafilokokus
- Tanda – tanda infeksi +
- Interna : kelenjar meibom → Relatif besar
Eksterna : Kelenjar Zeiss dan moll.

TERAPI → Kompres hangat, drainage, salep antibiotika

KOMPLIKASI → Sellulitis

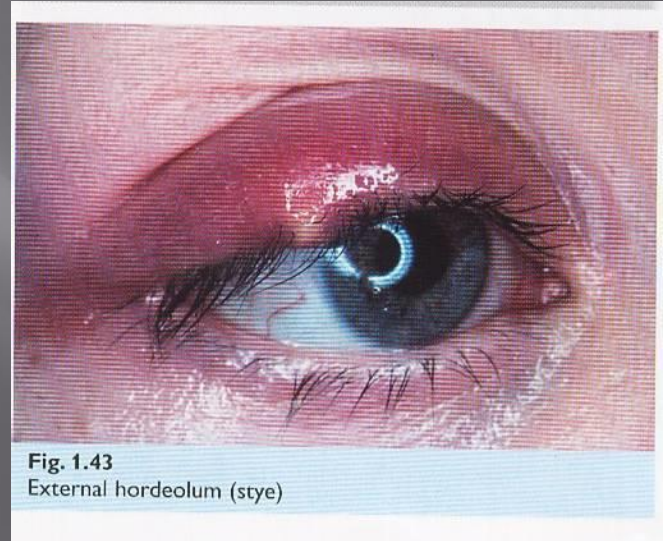


Fig. 1.43
External hordeolum (stye)

2. Khalasion

- Radang steril granulomatus → kelenjar meibom
- Biasanya pembengkakan mengarah ke sisi konj.
- Khalazion yang besar → menekan kornea → astigmatism
- Tanda radang -

TERAPI → drainage



Fig. 1.41
Incision of chalazion



3. Blefaritis

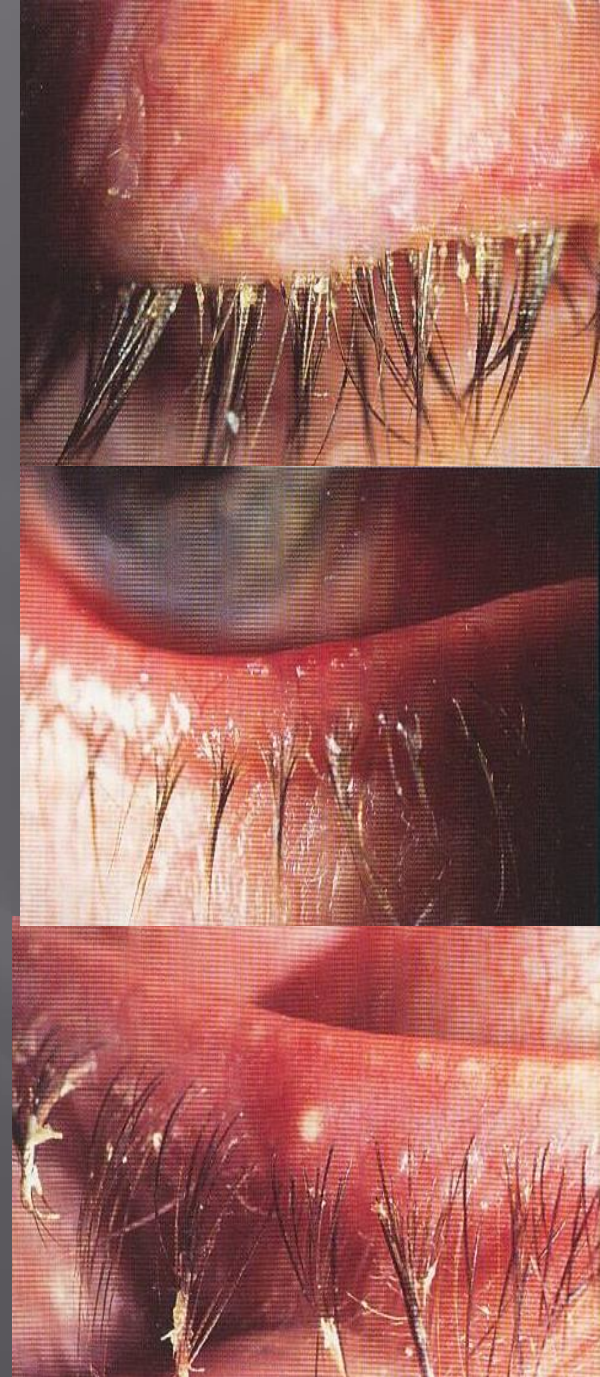
Radang pinggir kelopak mata

Gejala : pedih, gatal pada tepi kelopak mata

1. B. Ulcerosa
2. B. Squamosa
3. B. Angularis

Tx

- Eye lid hygiene
- Salep antibiotik

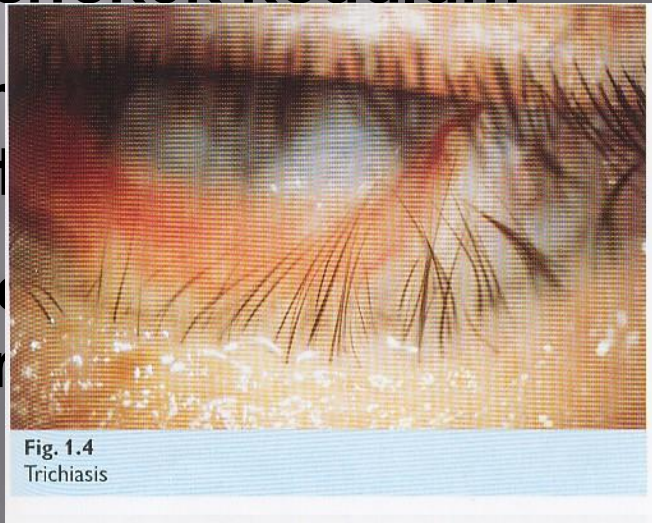


Kelainan Kedudukan Kelopak Mata

1. Entropion

Kelopak mata tertekuk kedalam

- a. Senil – degenerasi kelopak mata
- b. Sikatrikal – pada konj. Palpebra



2. Ektropion

**Kelopak mata tertekuk
keluar**

**Pada umumnya bilateral
pada usia lanjut →
terjadi relaksasi otot
orbikularis okuli**



Kelainan Bentuk Anatomis Kelopak Mata

1. Dermatokalasis & Blefarokalasis

- **Dermatokalasis**

Kulit kehilangan kelenturan, sehingga menggelambir menutupi kelopak mata

etiologi → aging : - Tua

- Sembab kelopak mata

- **Blefarokalasis**

Etiologi → Sembab berulang kali yang menyebabkan kulit kelopak mata kendur, berlebih berkerut tipis seperti sigaret



Fig. 1.135
Left aponeurotic ptosis and very thin upper lid skin resulting from blepharochalasis

blefarokhalasis

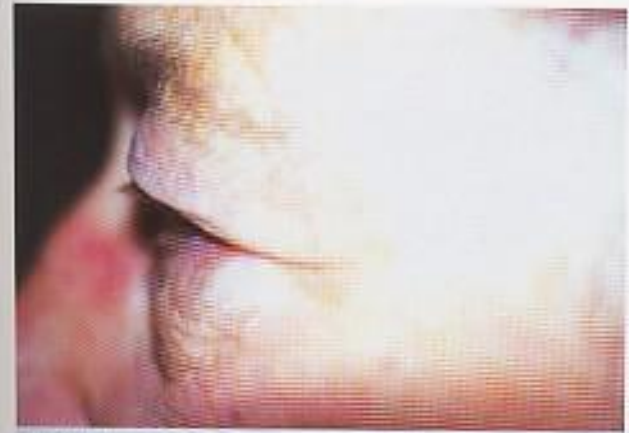


Fig. 1.134
Fat herniation in dermatochalasis

dermatokhalasis

2. Epikantus

Lipatan kulit vertikal di kantung medial → esotropia semu
→ Mata tampak juling jika sklera medial tidak terlihat oleh karena tertutup lipatan kulit



Blepharospasme

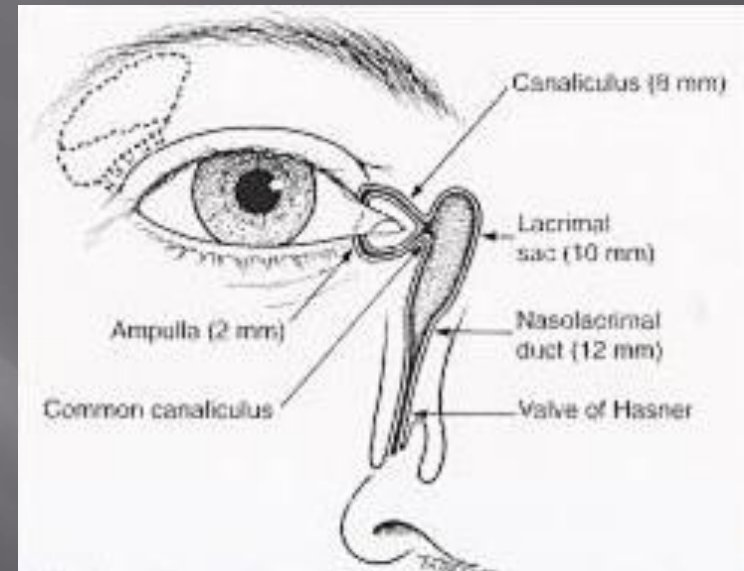
Kontraksi otot orbikularis okuli diluar kehendak dan bersifat terus menerus.
Pada umumnya bilateral.
oleh karena lesi iritatif di kornea



Apparatus Lakrimalis

App. Lakrimalis

- Kelenjar lakrimalis
- Pungtum
- Kanalikulus
- Kantong lakrimalis
- Duktus nasolakrimalis



App. Lakrimalis

Menghasilkan air mata → air mata mengalir membasahi permukaan kornea maupun konjungtiva

Gangguan lakrimalis

- Nrocoh = epifora
- Mata kering = keratitis sika

Infeksi App. Lakrimalis

1. Dakriosistitis

Inf. Kantong lakrimalis akut – menahun

Pada umumnya :

- uniteral
- sekunder karena sumbatan d.n.l

Penyebab Dakriosistitis akut :

- *S. aureus*
- *Streptococcus β hemolyticus*

Gejala

- keluar air mata & kotoran

Akut

- : - Radang
- Rasa sakit
 - Pembengkakan kantong lakrimalis → dipijat keluar nanah

Menahun :

- Nrocoh
- Bila dipijat → cairan mukoid

Pengobatan :

I. A. Dakriosistitis orang dewasa :

1. Akut → antibiotika sistemik → radang
2. Menahun → bebaskan sumbatan

B. Dakriosistitis infantil

1. Massage + antibiotika eye drop
2. Sondage
3. 8 bulan → aktif

II. Kanalikullitis

→ Inferior lebih sering

- merah, iritatif, sedikit sekret

2. Dakrioadenitis

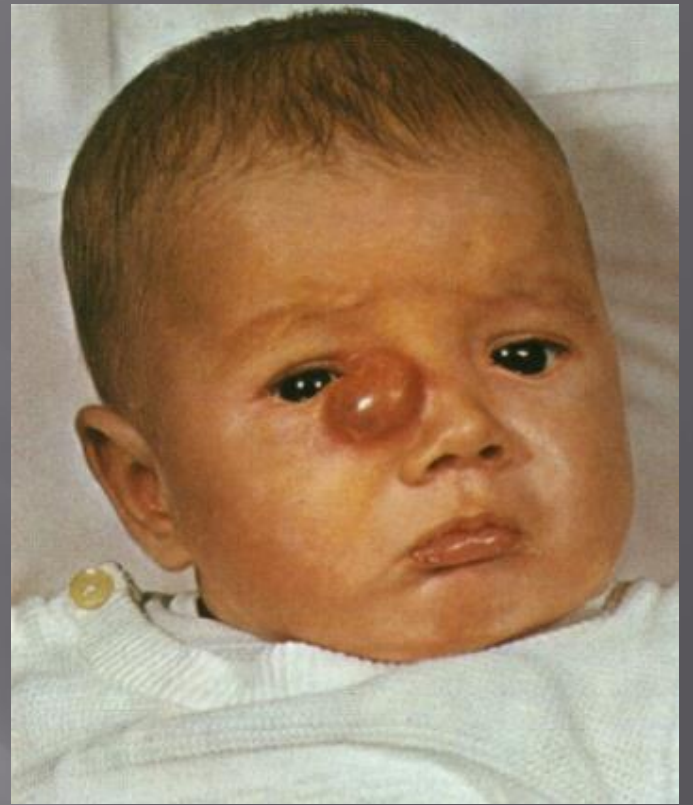
- **Radang akut kelenjar lakrimalis**
- **Unilateral**

Komplikasi :

- **Parotitis**
- **Morbili**
- **Influenza**

Terapi :

- **Antibiotika sistemik**
- **K/p. insisi**



AIR MATA

Hasil sekresi camp dr

- Kelenjar lakrimal mayor
 - Kelenjar lakrimal minor (assesori)
 - Sel goblets
 - Kelenjar meibom
-
- Lap. Superfisial
 - Bahan Lemak – hasil kelenjar meibom
 - Lap. Tengah
 - Aquos – hasil kelenjar lakrimalis
 - Lap. Dalam
 - Mukoid : (hasil sel goblett)

Pemeriksaan :

1. Produksi air mata

- Schirmer test : dengan kertas filter atau Schirmer strip
- Saccus konjungtiva. Biarkan 5 menit
- N membasahi : >10 mm



< 10 mm

prod. Air mata

2. Patency dari sistem pembuangan

Transkanal spoeling / irigasi duktus nasolakrimalis

Punctum sup / inf → masukkan cairan lewat spuit → akan masuk kerongkongan (= lancar / patent)

Pembuntuan + → keluar lewat punctum



Schirmer test

Keradangan App. Lakrimalis

Dakriosistitis : - keradangan sakkus lakrimalis
- Penyumbatan duct nasolakrimalis
inf. Coccus

Gejala : Nrocos / keluar air mata

- **Tanda** :
 - Pembengkakkan daerah medial / nasal
 - Nyeri
 - Tanda – tanda rad lain +
 - Sekret

Tx. Akut : kompres hangat

- antibiotik

Kronik : - Probing → irigasi
- Dakriosistorhinostomy

Canaliculitis

- Unilateral
- Srg canalis inferior
- Mata merah, iritasi
- Sekret + sedikit

Tx. : - Stenosis +
- Obstruksi + } Insisi + dilatasi

- Stenosis saja – probing
- Epifora berat : - canalikulotomy

Dakrioadenitis

- Keradangan kelenjar air mata
- Pembengkakan daerah superotemporal

Akut
Kronik

Tx. : - Kompres hangat

Akut - Antibiotik – lokal & sistemik
- Abses → insisi

Kronik: sesuai kausa

Fungsi air mata

1. Membasahi kornea & konjungtiva
2. Membutuhkan lapisan pada permukaan kornea/lapisan tear film
3. Mempunyai daya bacteriosidid / anti mikrobial

Lysosim
Antigen



Ig. G
Ig. A

4. Secara mekanis membilas / membersihkan permukaan depan dari mata

Dry eye syndrome / = keratokonjungtivitis sicca

Prod ↓ → kornea kering → keratitis +

Gejala :

Ngeres / seperti ada benda asing

Dry eye syndrome Hub. + dengan diff tear film komp.

- Rh. Arthritis
- Sjogren's syndrome

Tanda – tanda :

- Produksi air mata ↓
- Rasa panas
- Photosensitif
- Merah
- Nyeri
- Kesulitan menggerakkan kelopak mata

Komplikasi :

Kekeringan kornea



Keratitis

Uklus kornea – penipisan



perforasi



endoftalmitis



Sembuh dengan cikatrik & vaskularisasi



Visus

Pengobatan :

- ✓ Tergantung dari penyebabnya
- ✓ Defisiensi - diobati dengan air mata tiruan

Test lain untuk mengetahui kekeringan konj.



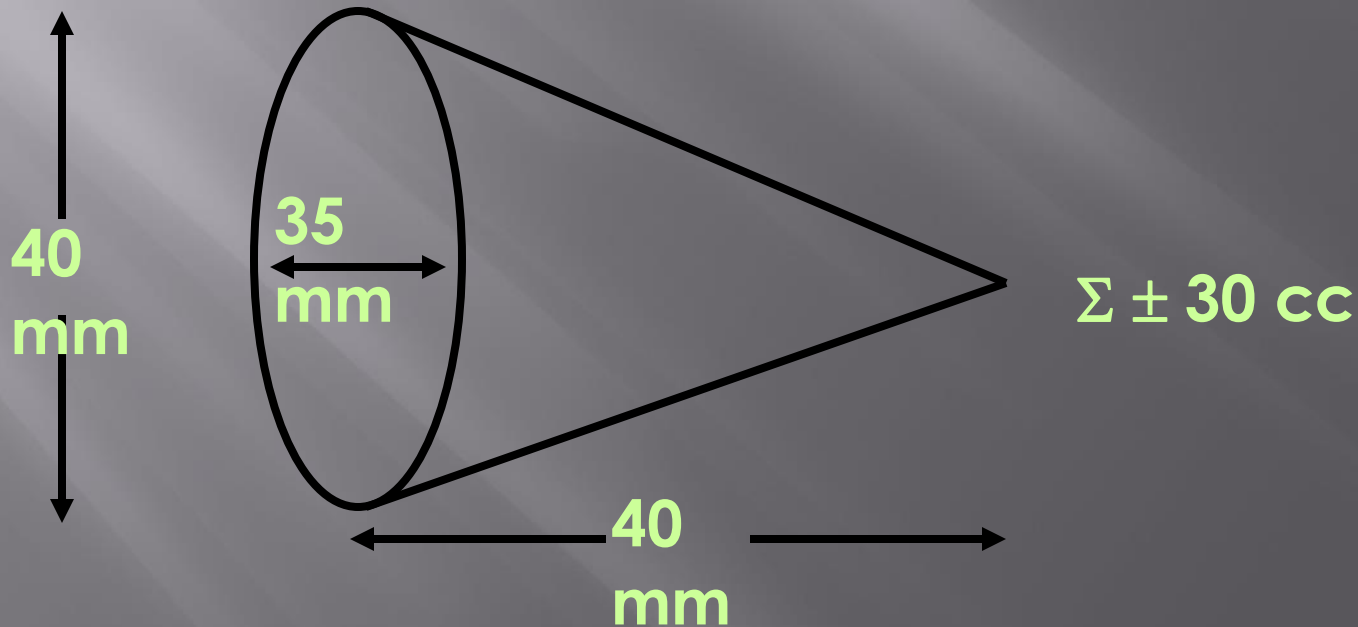
Rosa bengal staining

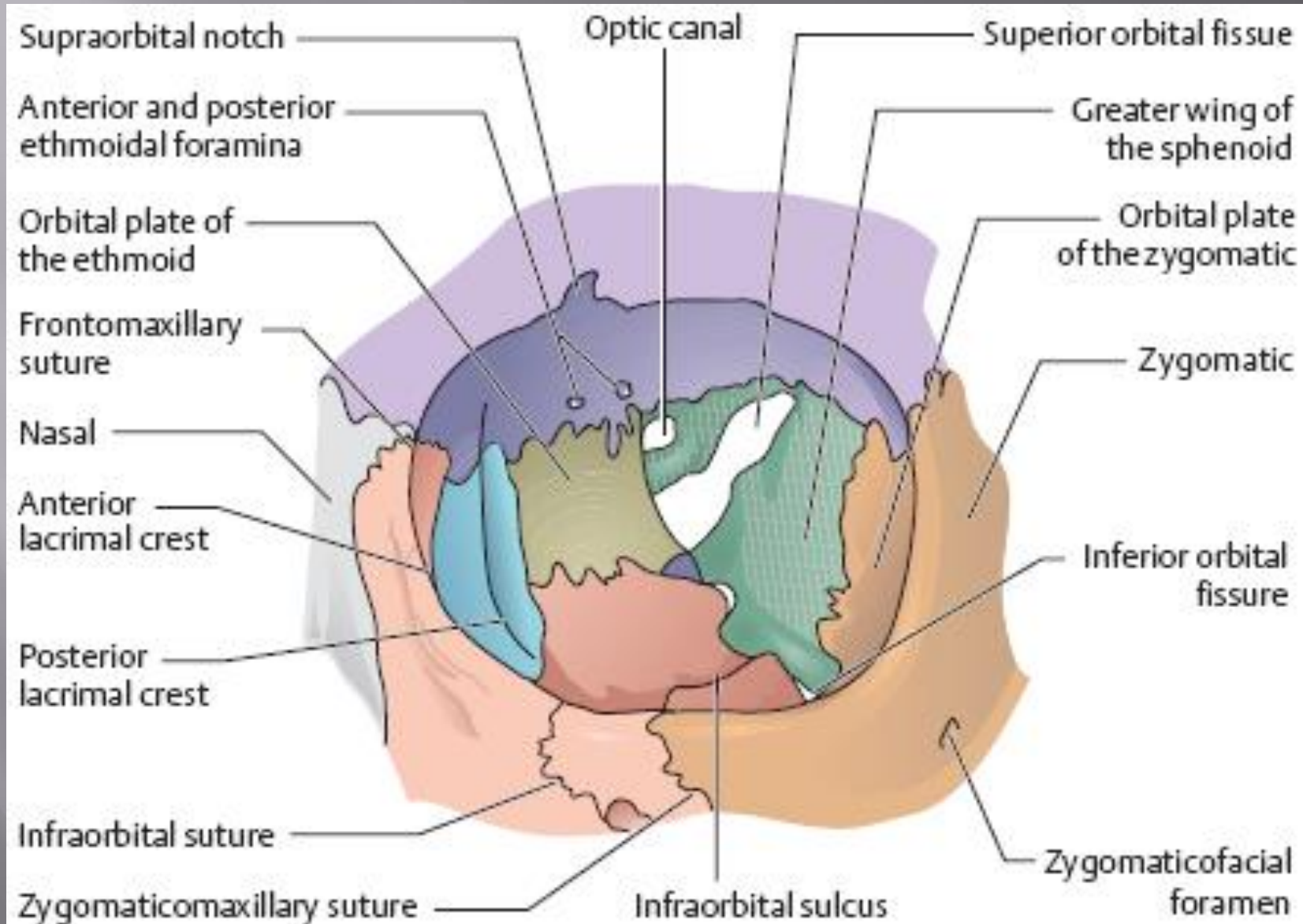
ORBITA ONKOLOGI

ANATOMI

Piramid →

- * Bola mata
- * Saraf
- * Otot
- * Jaringan lemak





Dinding Orbita :

Atap orbita

Os frontale

Os Sphenoid ala parva

Berhubungan : Fossa kranii ant

Sinus frontalis

Dinding lateral

Os Zygoma

Os frontale

Os Sphenoid ala magna

Berhubungan : Fossa kranii media

Fossa pterygopalatina

Dinding medial

Os Ethmoid

Os Frontale

Os Lakrimal

Os Maksila bgn frontal

Berhubungan : Sinus Ethmoid & Sphenoid
Kavum nasi

Dasar orbita

Os Maksila

Os Palatina

Os Zygoma

Berhubungan : Sinus maksila

Rongga tulang palatina

Orbital openings

Structures

Optic canal

- ❖ Optic nerve
- ❖ Ophthalmic artery

Superior orbital fissure

- ❖ Oculomotor nerve
- ❖ Trochlear nerve
- ❖ Abducent nerve
- ❖ Ophthalmic nerve:
 - Lacrimal nerve
 - Frontal nerve
 - Nasociliary nerve
- ❖ Superior ophthalmic veins

Inferior orbital fissure

- ❖ Infraorbital nerve
- ❖ Zygomatic nerve
- ❖ Inferior ophthalmic vein

Infraorbital canal

- ❖ Infraorbital nerve

Jaringan Lunak Rongga Orbita

- Peri orbita
Kanal Optik
- N.Optika
- Otot ekstra okuler
- Jar lemak
- Kel lakrimal
- Pemb.darah (art & vena) + saraf

TAHAPAN PEMERIKSAAN KLINIS PADA KELAINAN ORBITA

- 1. Tahap pem medis**
 - * Riwayat penyakit**
 - * Pem mata**
 - * Pem orbita : - ukur proptosis**
 - posisi proptosis**
 - dll**

2. Tahap pem Dx Penunjang

*** Radiologi standard**

(proyeksi ant,post,dan lat) ; Caldwell; Waters

Berguna untuk observasi :

- ukuran rongga orbita**
- destruksi tulang**
- gbran hiperostosis**
- fokus klasifikasi**
- pelebaran fissura Sph**
- pelebaran diameter for optikum**

- * MRI**
- * USG**
- * CT Scan**
- * Arteriografi/venografi**

3. Tahap konsultasi antar disiplin

- * Kons Bedah Saraf**
- * Kons THT**
- * Kons IPD / IKA**
- * Kons Anestesi**

KELAINAN ORBITA

- * Kongenital
- * Inflamasi & Infeksi
- * Trauma
- * Neoplasma

▣ **Kelainan kongenital**

- **Anophthalmi**
- **Microphthalmi**
- **Craniofacial clefting**
- **Tumor, mis Kista dermoid, lipodermoid, teratoma dll**

▣ Infeksi dan Inflamasi

1 . Cellulitis (Preseptal & Orbital)

Infeksi bakterial pada jar soft tissue dapat akibat dari :

- Direct spread
- Direct inoculation
- Bacteremie



2. Orbital Tuberculosis

3. Grave's Ophthalmopathy

4. Orbital Pseudotumor

5. Vasculitis



EXOPHTHALMOS

- Kausa :**
- * SOP dalam orbita
 - * Edema / perdarahan
 - * relaksasi otot ekstraokuler
 - * Pseudoexophthalmos →
retraksi kel mata
myopia grafis

Klasifikasi :

A . Akut : * sellulitis

*** perdarahan (trauma/spontan)**

*** emphysema**

B. Pulsating exophthalmos

*** Fistula karotis – sinus kavernosus**

*** tu vaskuler / aneurisma**

*** Cerebral pulsation ok
defek atap orbita**

C. Unilateral exoph.

- 1. Radang :**
 - celulitis
 - pan ophthalmitis
 - thrombosis sin. Cavernosus
- 2. Vaskuler :**
 - perdarahan
 - aneurysma
- 3. Trauma :**
 - perdarahan
 - emphysema
 - fraktur
- 4. Tumor :**
 - intra okuler
 - intra orbita
 - primer
 - metastatik

D. Bilateral exoph.

- Endokrin → thyroid ophth.
(Grave's disease)
- High myopia
- Congenital macrophthalmia
- Tumor → Limfoma
Metastatik

ENOPHTHALMOS

- Bola mata tertarik ke dalam rongga orbita



Oleh karena :

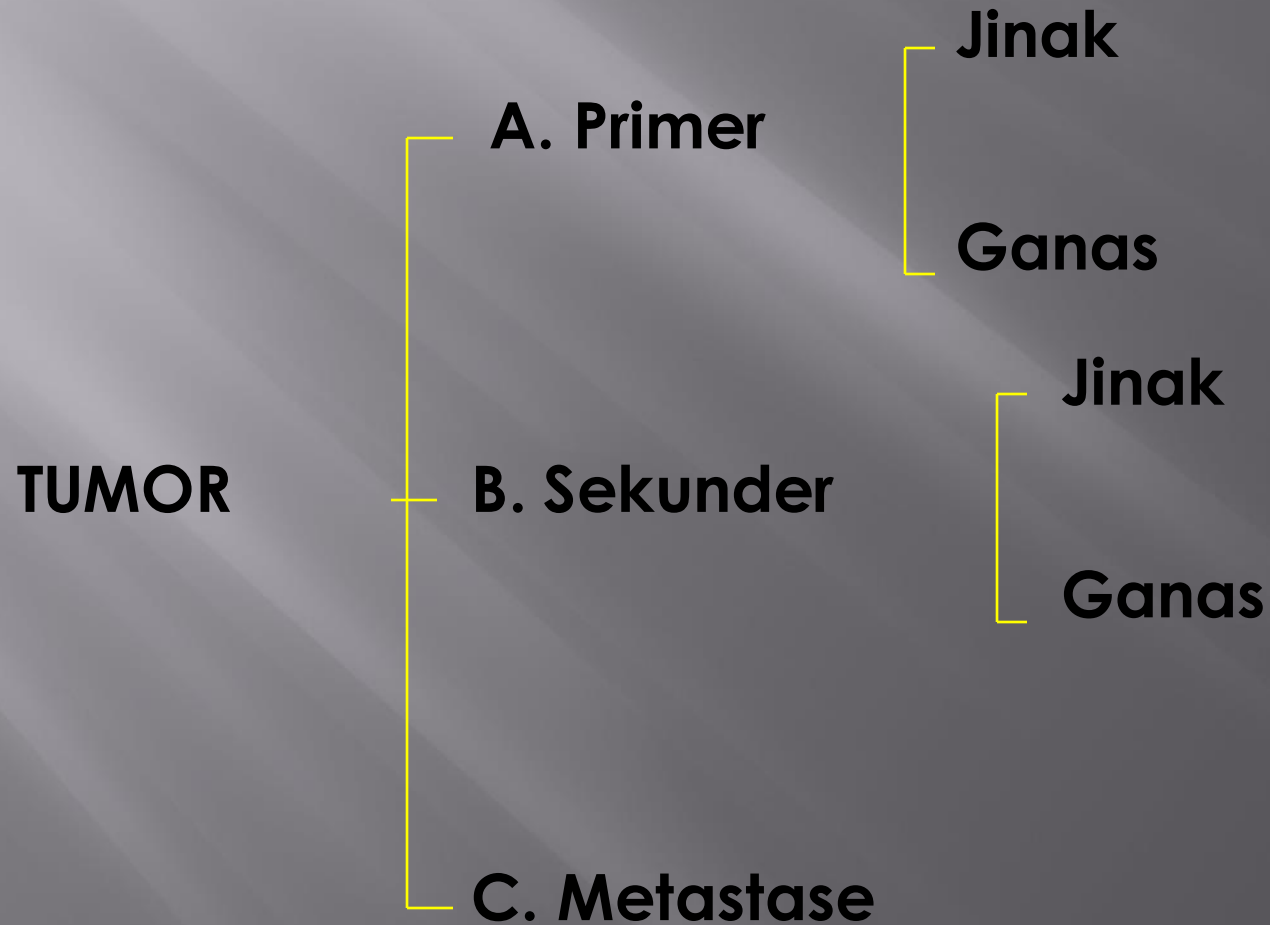
- Usia tua → senile orbital fat atrophy
- Usia muda → Horner's synd.



enophth-hemifacial atrophy

- Blow out fracture

TUMOR



A. TUMOR PRIMER

1a. Tumor Jinak Konjungtiva

- Nevus
- Papiloma
- Granuloma
- Dermoid Tumor
 - Tu. Congenital
 - tx. kosmetik
- Dermolipoma
 - Fibroma
 - Angioma
- Lymphoma & lymphoid hyperplasia

1b. Tumor Ganas Konjungtiva

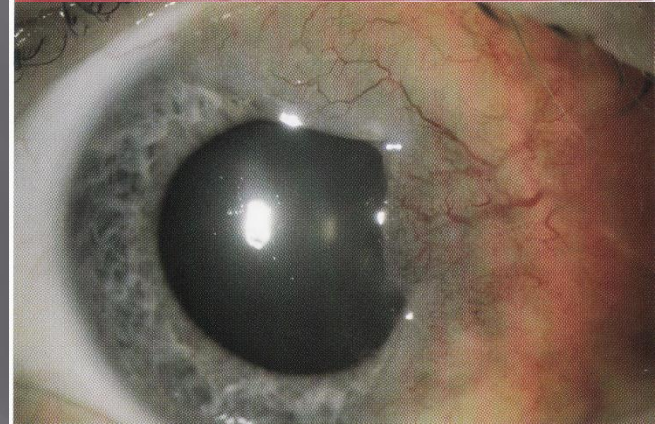
a. Carcinoma

- sering didaerah limbus, pada fissura interpalpebra sering mirip pterygium



b. Melanoma Maligna

- jarang
- kalau terlokalisir → excisi lokal
- kalau berasal dari choroid → excenterasi



c. Lympho Sarcoma

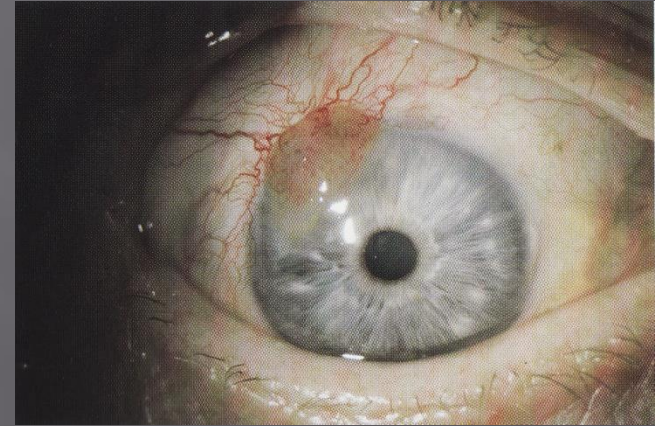
- jarang



2a. Tumor Jinak Kornea

2b. Tumor Ganas Kornea

- epithelioma
- melanoma
- Tu. epithel Cornea, sgt jrg
Perluasan dari Ca. conj. → epithel kornea



3a. Tumor Jinak Intra Okuli

i . Nevus

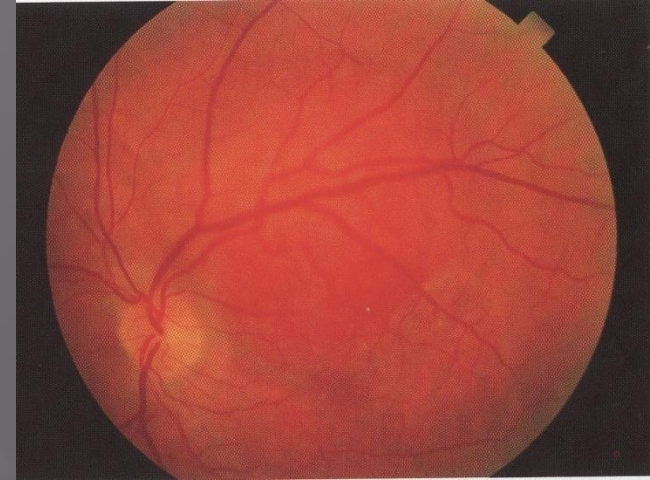
- asal : iris, corpus siliaris, khoroid
→ lesi berpigmen di stroma jaringan
- Sulit dibedakan :
choroidal melanoma & melanoma maligna



ii . Hemangioma Khoroid

banyak didapatkan pada

kasus dengan syndr sturge – webber



iii . Glaukoma infantil (unilateral)

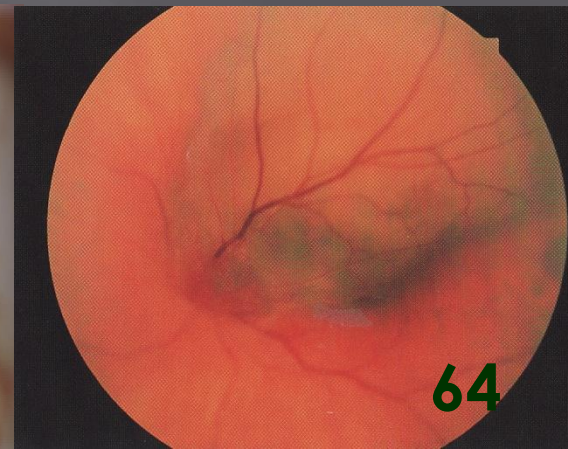
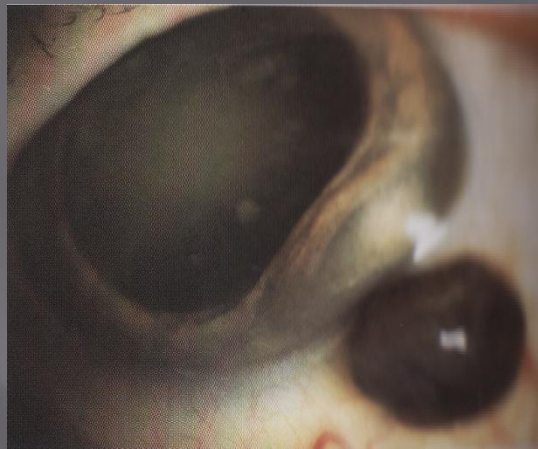
sulit dibedakan dengan melanoma khoroid

**tx. (-) → enukleasi pada pend dengan
nyeri hebat**

3b. Tumor Ganas Intra Okuli

Melanoma Maligna

- unilateral, 85 % dari khoroid
9 % dari badan siliar
6 % dari iris
- waspada metastase ke hepar → paru
- tx.: enukleasi → k/p eksenterasi

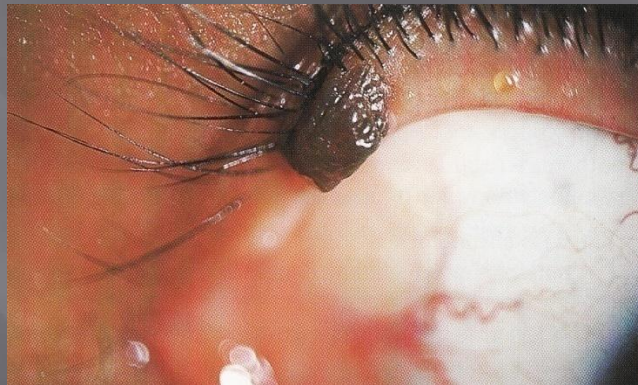


B. TUMOR SEKUNDER

1a. Tumor Jinak Kelopak Mata

i. Nevus → penumpukan pigment

Tx. : excisi & plastik rekonstruksi
(untuk kosmetik)



ii. Verrucae

- biasanya sepanjang pinggir kel. mata
- sebab : virus
- tx. excisi, kauter, plastik rekonstruksi

iii. Molluscum contagiosum

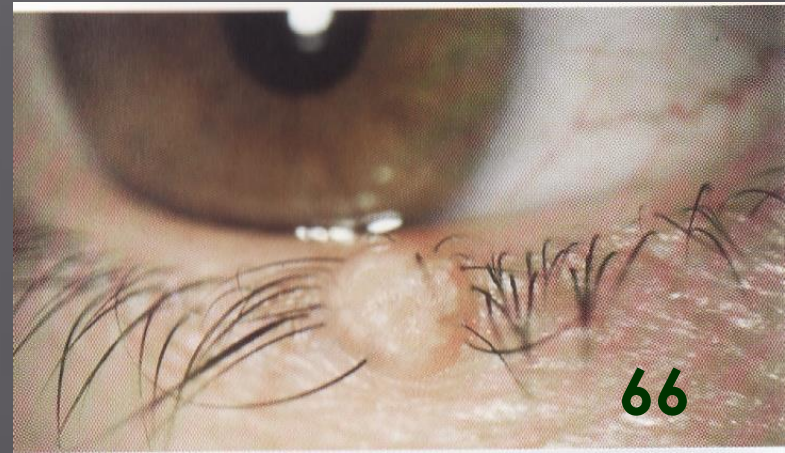
- jarang, simetris, bagian sentral umbilicated
disepanjang pinggir kel. mata

sebab : virus

excisi - kauterisasi

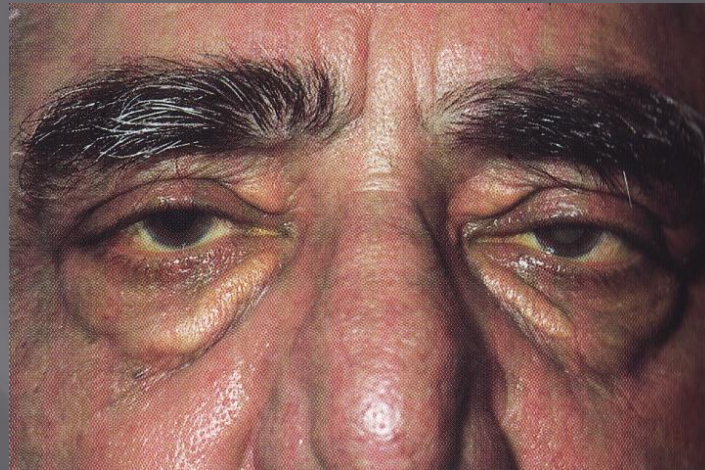
-

- tx.



iv. Xanthelasma

- Kelaianan di perm. ant. kel. mata, bilateral, kekuningan, berkerut-kerut dikulit
- Pada orang tua
- tx. excisi, plastik rekonstruksi (u/ kosmetik)



v. Hemangioma

2 tipe utama kel. vask. kongenital pd kel. Mata :

➤ Hemangioma cavernosa

- kebiruan

ukuran ∞ jumlah darah

Hemangioma kapiler

kemerahan

nyeri

konservatif, kec. ggan (+) → excisi,

freezing dgn CO

Tidak dianjurkan radiasi, o.k. sikatrik

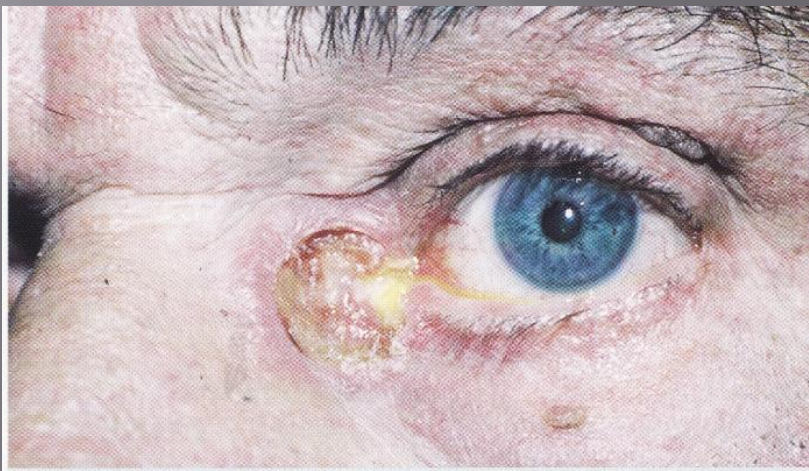
dan kerusakan luas



1b. Tumor Ganas Kelopak Mata

i. Carcinoma

- CA pada kel. mata tertinggi dari tumor ganas mata → > 50 tahun
- Tersrg pada tepi kel. mata bwh didekat canthus medial →
95 % : Basal cell ca
5 % : Squamous cell ca.
Meibomian gland ca.
- Tumbuh lambat, nyeri (–) infiltrative → penyebaran melalui sistem limpatik
- Tx. : wide excisi + plastik rekonstruksi



ii. Sarcoma

- Jarang terjadi
→ biasanya oleh karena. perluasan ke ant
dari “ orbital sarcoma”
- Tx. : excisi & radioterapi

iii. Melanoma maligna



-  dikulit diseluruh permk tubuh
- Tidak selalu pigmented
- Tx. : wide excisi - plastik rekonstruksi
- Prognosis tergantung pada invasi di dalam dan kedalam jaringan

C. TUMOR METASTASE

- **Ca Mamma**
- **Neuroblastoma**
- **dll**

Orbital Neoplasma

1. Hemangioma
Kapiler dan kavernosa
2. AVMalformation
3. Neural Tumor
mis: optic glioma, neurofibroma,
meningioma.
4. Tumor kel Lakrima.



Orbital Trauma

1. Midfacial fracture (Le fort)

LF I - Fr Maksila diatas gigi

LF II - Berbtk Piramid

Fr ddg medial dasar orbita

LF III - Fr seluruh skleton wajah,
menyebabkan craniofacial
disjunction.

2. Orbital fractur

- Zygoma**
- Fr Atas orbita**
- Fr Medial orbita**
- Fr Dasar orbita**

TERIMAKASIH